一页流程｜真菌性角膜溃疡：病损切除联合伏立康唑

研究解读路径 · 不等同指南推荐 · 2026

1 病原确认

培养 / 涂片 / 共焦任一见菌丝或孢子 → 核对研究入选条件。

2026 刊 p123 / PDF2

2 是否符合研究范围?

中央 / 旁中央且浸润≤ 1/2 角膜厚度? 否 → 不适用本文路径；是 → 核对排除条件。

2026 刊 p123 / PDF2

3 初始抗真菌治疗

按本文术前方案记录治疗； 3~7 d 无明显好转 → 研究中进入手术评估。

2026 刊 p123 / PDF2

4 研究手术方案

病损切除联合多点基质伏立康唑；总注射体积原文未明确，不补造。

2026 刊 p123 / PDF2

5 术后是否再浸润?

每日裂隙灯；再浸润 → 原文追加结膜下注射（剂量未明确）；无 → 继续观察愈合。

2026 刊 p123 / PDF2

6 随访与研究边界

复查视力 / 共焦 / 愈合；统一停药与复诊阈值未明确。此为研究路径，不是指南推荐。

2026 刊 p123、 125 / PDF2、 4

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。